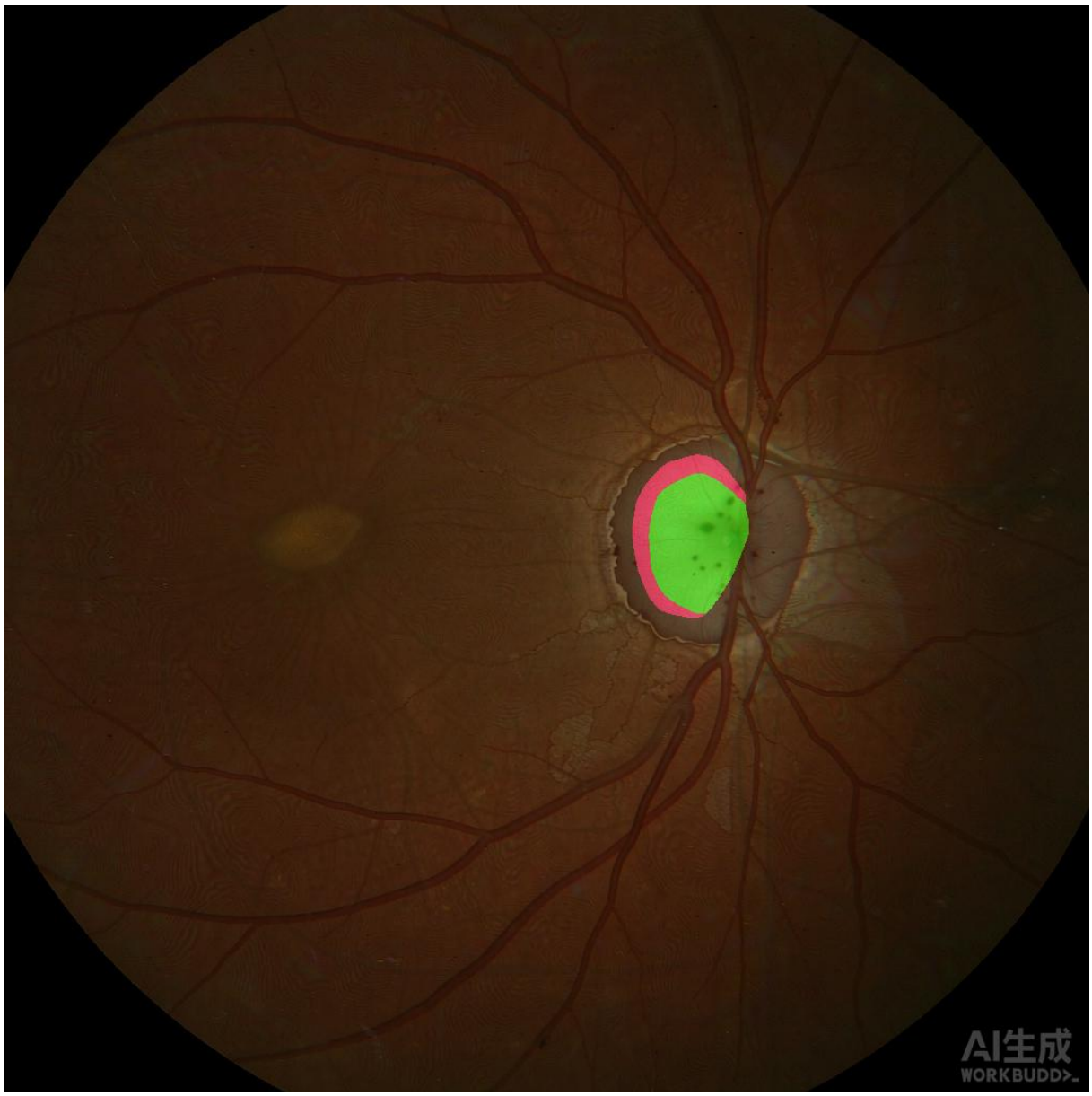
青光眼诊断报告



杯盘比（C/D）：0.85

红色 = 视盘，绿色 = 视杯

最终诊断摘要

综合诊断报告

一、病例概要

患者男性，62 岁，因体检发现眼压升高就诊。既往高血压病史约 10 年，规律服用氨氯地平，血压约 135/85 mmHg；母亲有原发性开角型青光眼（Primary Open-Angle Glaucoma, POAG）病史。否认糖尿病、高度近视、眼部外伤及长期糖皮质激素使用史。近半年偶有夜间视物模糊，无眼痛

、虹视等急性症状。

二、关键检查发现

1. 眼压（Intraocular Pressure, IOP）

多次非接触眼压测量均值右眼 26 mmHg、左眼 24 mmHg，双眼对称性轻中度升高，高于正常参考上限（21 mmHg）。房角镜检查示双眼房角开放、色素沉着 I 级，不支持闭角机制。需注意非接触眼压受中央角膜厚度（Central Corneal Thickness, CCT）及测量变异影响，尚待校正。

2. 视盘形态

右眼彩色眼底照示视杯显著扩大，杯盘比（Cup-to-Disc Ratio, CDR）约 0.85，盘沿变窄，以颞上、颞下盘沿为著，血管走行呈屈膝样改变，符合青光眼性视神经病变形态学特征。左眼本次未提供影像，视盘形态待基线评估。

3. 视网膜神经纤维层（Retinal Nerve Fiber Layer, RNFL）

光学相干断层扫描（Optical Coherence Tomography, OCT）示右眼上方及下方象限 RNFL 变薄，与视盘改变及视野缺损的解剖定位一致；左眼 RNFL 尚在正常范围。

4. 视野（Visual Field）

右眼 Humphrey 24-2 示鼻侧阶梯样缺损，平均偏差（Mean Deviation, MD）-4.21 dB、模式标准差（Pattern Standard Deviation, PSD）3.86 dB，属早期至中度局限性缺损，与右眼结构损害相互印证；左眼未见明确缺损。

5. 视力与屈光

裸眼视力右眼 0.8、左眼 0.9，矫正视力双眼均达 1.0，中心视力保存良好，黄斑功能未见明显受损。

三、诊断与推理

综合双眼 IOP 升高、房角开放，右眼 CDR 显著扩大、RNFL 上下方局限性变薄及对应鼻侧阶梯样视野缺损，三者结构-功能定位一致，右眼符合原发性开角型青光眼（POAG）诊断，分期属早中期。左眼仅眼压升高，视盘形态、RNFL

及视野尚无明确损害证据，考虑为高眼压症（Ocular Hypertension, OHT）或早期 POAG 疑似，需密切随访。

支持该判断的依据包括：年龄 >60 岁、一级亲属 POAG 家族史、双眼眼压升高均为明确的青光眼危险因素；右眼已具备特征性结构与功能损害且相互印证。需鉴别的情形包括：非接触眼压未行 CCT 校正，真实眼压水平待确认；左眼眼压升高可能受角膜厚度影响；夜间视物模糊需与眼压波动、早期白内障及对比敏感度下降相鉴别，目前不具定位意义。此外，患者无长期糖皮质激素暴露，现有降压药物（氨氯地平）对眼压无明确不良影响，药源性眼压升高依据不足。

四、建议

1. 完善基线检查

行 Goldmann 压平眼压（Goldmann Applanation Tonometry, GAT）及 CCT 测量以校正真实眼压；补充 24 小时眼压曲线或日间多点眼压测量评估眼压波动；完成双眼视盘立体照相、视盘 OCT（含盘沿面积、RNFL 及神经节细胞复合体 GCC）基线记录；左眼加做基线视野及 RNFL 定量；右眼视野复查以确认缺损可重复性，并关注固视丢失及假阳性/假阴性率等可靠性指标。建议完善主觉验光及对比敏感度、暗适应评估，作为功能基线。

2. 目标眼压

鉴于右眼已存在视野缺损，建议个体化目标 IOP 较基线下降 25%–30%（右眼约 16–18 mmHg），并依据随访中结构与功能是否进展动态调整。

3. 降眼压治疗

可起始局部前列腺素类似物滴眼液（如拉坦前列素）每晚一次，兼顾夜间眼压控制，其全身吸收少、对高血压患者心血管安全性较好。若需联合 β 受体阻滞剂类滴眼液（如噻吗洛尔），用药前应评估静息心率、血压及心肺禁忌（哮喘、慢性阻塞性肺病、心力衰竭、传导阻滞），并注意与氨氯地平的叠加低血压效应。处方时进行滴眼技术培训（单次一滴、滴后压迫鼻泪管 1–2 分钟、多药间隔给药），以提高依从性并减少全身吸收。左眼是否同步干预可结合眼压曲线、结构基线及风险评估综合决定。用药后 4–6 周复评眼压、耐受性及结膜充血等不良反应。

4. 随访计划

初始每 1－3 个月复查 IOP；每 3－4 个月复查视野；每 6－12 个月复查 OCT RNFL/GCC，长期监测 MD 变化率及结构进展速度。出现视野缺损扩大或 RNFL 持续变薄时升级治疗（联合用药或考虑激光/手术）。左眼作为高危对侧眼应提高监测频率。

5. 全身因素管理

继续平稳控制血压，与内科沟通避免夜间血压过度下降，以免影响视神经灌注；结合年龄及家族史筛查空腹血糖或糖化血红蛋白、血脂；鼓励适度运动、限盐、戒烟等生活方式干预。持续核实是否存在间断或隐匿性糖皮质激素暴露（含皮肤科、呼吸科用药及非处方滴眼液）。

6. 家族史延伸与患者教育

建议患者一级亲属（子女）行青光眼筛查，包括眼压、眼底及视神经评估。告知青光眼为慢性进展性疾病，需终身随访及坚持用药；避免自行长期使用含激素眼药或全身激素；出现眼痛、视力骤降、虹视或视野范围缩小等情况应及时就诊。将眼科随访节点纳入慢病管理档案，与高血压随访同步安排。

五、总结

本例为双眼眼压升高、右眼原发性开角型青光眼（早中期）、左眼高眼压症/疑似青光眼。右眼已具备明确的结构与功能损害证据，左眼处于高危监测阶段。当前首要任务为完善眼压校正与结构、功能基线检查，启动右眼降眼压治疗并设定个体化目标眼压，同时建立规范的长期随访与全身危险因素协同管理方案。

本报告由医学 AI 助手自动生成，仅供研究参考，不作为临床诊断依据。